

CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE DE SÃO PATRÍCIO.
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA ENFRENTAMENTO DO COVID - 19.

SÃO PATRÍCIO – GO



PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA ENFRENTAMENTO DO COVID - 19.

PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PATRICIO – GO
JOÃO EUSTÁQUIO CORDEIRO

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
MARIA APARECIDA DE MACEDO ALMEIDA

COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA (PSF)
ELAINE XAVIER LEANDRO

MÉDICA DA ATENÇÃO BÁSICA
DEBORAH RAYSSA FERNANDES CHAVES

ODONTÓLOGA DA ATENÇÃO BÁSICA
BRUNA RANGEL

FISIOTERAPEUTA DA ATENÇÃO BÁSICA
LORENA APª. BORGES

FARMACÊUTICA DA ATENÇÃO BÁSICA
MARIANY DE FREITAS MARTINS



SUMÁRIO

1 - INTRODUÇÃO.....4

2 - OBJETIVOS.....5

3 - SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA NO BRASIL.....6

4 - CACTERÍSTICAS GERAIS SOBRE A INFECÇÃO HUANA COVID – 19.....6

5 - ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS EM COMBATE AO COVID - 19.....7

6 - ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NA UNIDADE BÁSICA D.....8

7 - MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE.....10

8 - ROTEIRO DE INVESTIGAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA (COVID-19).....11

9 - FLUXOGRAMA APS 22

10 - FLUXOGRAMA DOMICILIAR 23

11- CONSIDERAÇÕES FINAIS 24

12 - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 25



1 INTRODUÇÃO

Em 31 de dezembro de 2019, o escritório da OMS na China foi informado sobre casos de pneumonia de etiologia desconhecida detectada na cidade de Wuhan, província de Hubei. As autoridades chinesas identificaram um novo tipo de Coronavírus, que foi isolado em 07 de janeiro de 2020. Em 11 e 12 de janeiro de 2020, a OMS recebeu mais informações detalhadas, da Comissão Nacional de Saúde da China, de que o surto estava associado a exposições em um mercado de frutos do mar, na cidade de Wuhan.

Em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) em razão da disseminação do Coronavírus, após reunião com especialistas. Em 03 de fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde declarou Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da infecção humana da doença pelo Coronavírus 2019 (COVID-19), por meio da Portaria MS n° 188, e conforme Decreto n° 7.616, de 17 de novembro de 2011. A Portaria MS n° 188 também estabeleceu o Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública (COE-nCoV) como mecanismo nacional da gestão coordenada da resposta à emergência no âmbito nacional, ficando sob responsabilidade da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS/MS) a gestão do COE-nCoV.

Neste plano serão abordadas ações que favoreceram a não proliferação da doença covid-19.

No entanto, este plano encontra-se em consonância com o Decreto Municipal de nº. 115/2020.



2 OBJETIVOS

2.1 Objetivos Gerais

- Promover a prevenção e evitar a transmissão de casos de infecção pelo COVID-19 no município de São Patrício/GO.

2.2 Objetivos Específicos

- Garantir a detecção, notificação, investigação de casos suspeitos de forma oportuna;
- Organizar o fluxo de ações de prevenção e controle do Coronavírus;
- Estabelecer insumos estratégicos na utilização de casos suspeitos;
- Traçar estratégias para redução da transmissão da doença, por meio do monitoramento e controle dos pacientes já detectados;
- Intensificar ações de capacitação dos profissionais de saúde da rede municipal de saúde;
- Garantir adequada assistência ao paciente, com garantia de acesso e manejo clinico adequado;
- Monitorar e avaliar a situação epidemiológica para orientar a tomada de decisão;
- Definir as atividades de educação, mobilização social e comunicação que serão implementadas;
- Preserva as pessoas , concretizando sobre a proliferação das doenças;
- Promover campanhas no sentido de manter as pessoas fora das aglomerações.



3 Situação Epidemiológica no Brasil

De 03 de janeiro a 07 de fevereiro de 2020, o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS) Nacional capturou 85.229 rumores, foram analisados 624 rumores relevantes e, destes, 238 eram específicos sobre infecção humana por Coronavírus. Entre 18 de janeiro a 07 de fevereiro de 2020, a Secretaria de Vigilância em Saúde recebeu a notificação de 107 casos para investigação de possível relação com a Infecção Humana por Coronavírus. Todas as notificações foram recebidas, avaliadas e discutidas, caso a caso, com as autoridades de saúde dos Estados e Municípios. Em 22 de janeiro foi notificado o primeiro caso suspeito no Brasil que atendia à definição de caso. Dos 107 casos notificados, 34 (32%) atenderam à definição de caso suspeito e 73 (68%) foram classificados como excluídos, por não atenderem à definição de caso, contudo esses casos estão sendo monitorados conforme protocolo da vigilância da Influenza.

O Brasil registrou o primeiro caso confirmado da infecção pelo COVID-19. Trata-se de um paciente do sexo masculino, 61 anos, residente no estado de São Paulo, histórico de viagem recente para Itália, apresentou febre, tosse, dor de garganta e coriza.

4 Características gerais sobre a Infecção Humana por COVID-19

Os Coronavírus causam infecções respiratórias e intestinais em humanos e animais, são altamente patogênicos (SARS e MERS). Na infecção Humana por COVID-19 o espectro clínico não está descrito completamente, bem como não se sabe o padrão de letalidade, mortalidade, infectividade e transmissibilidade. Não há



vacina ou medicamento específico disponível. O tratamento é de suporte e inespecífico.

Os Coronavírus são uma grande família de vírus comuns em muitas espécies diferentes de animais, incluindo camelos, gado, gatos e morcegos. Raramente, os Coronavírus animais podem infectar pessoas e depois se espalhar entre pessoas como MERS-CoV e SARS-CoV. No início, muitos dos pacientes com surtos de doenças respiratórias causadas pelo Coronavírus 2019 (COVID-19) em Wuhan, na China, tinham alguma ligação com um grande mercado de frutos do mar e animais vivos, sugerindo a disseminação de animais para pessoas. No entanto, um número crescente de pacientes, supostamente não teve exposição ao mercado de animais, indicando a ocorrência de disseminação de pessoa para pessoa. Sendo que a prevenção para a não contaminação é o isolamento social.

5 Atribuições da Secretaria Municipal de Saúde e Ações a Serem Desenvolvidas em Combate ao COVID – 19

Este Plano de Contingência foi elaborado com o objetivo de criar e executar ações, condutas, planos e protocolos de atendimentos, em âmbito da Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Patrício/GO, para o enfrentamento da pandemia, doença infecciosa viral respiratória (COVID-19), causada pelo agente novo coronavírus, seguindo os protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Dentre as atribuições a serem seguidas, podemos citar:



6 Atendimento na Unidade Básica de Saúde Médico de Urgência e Emergência

- Serão priorizados os atendimentos de pacientes que apresentam sintomas, tais como: tosse, febre >37,8ºC e dificuldades respiratórias, sem necessidade de agendamento prévio;
- Atendimento aos pacientes que apresentem outros sintomas e necessitem de atendimento médico será realizada uma triagem com base no Protocolo de Manchester via ligação telefônica, por um profissional de saúde da unidade, nos números 62 3340-0054 ou 62 98486-1663.
- Captura de rumores diante de casos suspeitos de infecção por COVID-19, notificação de casos suspeitos e análise das informações das unidades notificantes;
- Ampla divulgação de informações e análises epidemiológicas sobre a doença;
- Organização do fluxo de assistência diante de casos suspeitos de infecção por COVID-19, o que inclui regulação de casos;
- Regulação de pacientes contaminados pelo Covid – 19, no sistema http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolo_tratamento_influenza_2017.pdf

6.1 Transporte de Pacientes em Veículos da Saúde

- Fica suspenso o transporte de pacientes para outros centros de saúde para consultas, tratamentos e cirurgias eletivas, salvo aqueles em situação de urgência e emergência que coloque em risco a vida do munícipe. Também será mantido o transporte de pacientes que realizam o tratamento de oncologia, hemodiálise, bem como as ultrassonografias obstétrica e os laboratórios de análises clínicas.

6.2 Atendimento Odontológico (Dentista)

- O atendimento odontológico (dentista) será realizado apenas em casos de emergência, a ser constatada em triagem a ser feita com a Auxiliar de Consultório Dentário – ACD.



6.3 Realização de Curativos

- A realização dos curativos, em pacientes que necessitam do atendimento, serão realizados apenas nos domicílios, mediante agendamento nos números 62 3340-0054 ou 62 98486-1663.

6.4 Coleta de Material Citopatológico de Colo do Útero (Prevenção)

- Fica suspenso até segunda ordem, as coletas de material citopatológico de colo de útero (prevenção).

6.5 Realização de Exames Laboratoriais

- Os exames laboratoriais na referida Unidade de Saúde do munícipio ficam suspensos até segunda ordem, sendo realizados apenas aqueles de emergência.

6.6 Funcionamento da Farmácia Básica

- A Farmácia Básica estará funcionando apenas no período matutino e vespertino, das 7hs às 17hs, e com o prévio agendamento para retirada de medicamentos nos números 62 3340-0054 ou 62 98486-1663.

6.7 Funcionamento da Sala de Vacinas

- Ficam suspensos a administração de vacinas de rotina, exceto as vacinas BCG e Hepatite B em recém nascidos, mediante agendamento prévio nos números 62 3340-0054 ou 62 98486-1663.



- A campanha anual contra a Influenza teve início no dia 23/03/2020, segue seu calendário normal de aplicação de acordo com a faixa etária determinada pela OMS.
- A campanha anual contra o Sarampo, teve início no dia 23/03/2020, segue seu calendário normal de aplicação de acordo com a faixa etária determinada pela OMS.

6.8 Funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde

- O atendimento administrativo ao público vem sendo realizado via telefônica nos números 62 3340-0066 ou 62 98644-0985. Já o atendimento presencial é feito de forma que prioriza os casos de emergências e urgências.

6.9 Agentes Comunitários de Saúde – ACS e Agentes de Combate às Endemias – ACE

- As vistas domiciliares dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Endemias seguem normal, porem os mesmos usando os EPIs adequados.

7 Medidas de Prevenção e Controle para Pssistência aos Casos Suspeitos e Confirmados de Infecção da Doença Pelo Coronavírus 2019 (COVID-19)

Considerando a importância orientar todos os profissionais de saúde do município de São Patrício/GO frente às condutas para prevenção e controle de infecção por COVID-19, orienta-se que:

- O serviço de saúde deve garantir que as políticas e práticas internas minimizem a exposição a patógenos respiratórios, incluindo o COVID-19;



- As medidas devem ser implementadas antes da chegada do paciente ao serviço de saúde, na chegada, triagem e espera do atendimento e durante toda a assistência prestada;

- O serviço de saúde deve garantir condições adequadas para higienização das mãos (sabonete líquido, lavatório/pia, papel toalha e lixeira com abertura sem contato manual além de dispensador com preparação alcoólica) e fornecimento de equipamentos de proteção individual.

- Casos suspeitos deverão utilizar máscara cirúrgica e orientados quanto à etiqueta respiratória (usar lenços de papel ao tossir, espirrar ou tocar em secreção nasal);
- A prática frequente de higienização das mãos deverá ser enfatizada;

- Os profissionais de saúde deverão realizar higiene das mãos e utilizar os equipamentos de proteção individual – EPI (máscara cirúrgica, avental impermeável e luvas de procedimentos);

8 Roteiro de Investigação Epidemiológica – COVID-19

Definições de Caso Suspeito de Doença Respiratória Aguda 2019-NCOV, Conforme Critérios Clínicos e Epidemiológicos

Situação 1: Febre[1] **E** pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar, batimento das asas nasais entre outros) **E** Histórico de viagem para área com transmissão local, nos últimos 14 dias antes do início dos sintomas. **Ou**

Situação 2: Febre[1] **E** pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar, batimento das asas nasais entre outros) **E** Histórico de contato próximo de



caso[2] suspeito para o coronavírus (2019-nCOV) nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais ou sintomas.

Situação 3: Febre[1] **OU** pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar, batimento das asas nasais entre outros) **E** contato próximo de caso[2] confirmado de coronavírus (2019-nCOV) em laboratório, nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais ou sintomas.

Fonte: BE n. 1, COE/MS, 2020

Observações:

[1]Febre pode não estar presente em alguns casos como, por exemplo, em pacientes jovens, idosos, imunossuprimidos ou que em algumas situações possam ter utilizado medicamento antitérmico. Nestas situações, a avaliação clínica deve ser levada em consideração.

[2]Contato próximo é definido como: estar a aproximadamente dois metros (2 m) de um paciente com suspeita de caso por novo coronavírus, dentro da mesma sala ou área de atendimento, por um período prolongado, sem uso de equipamento de proteção individual (EPI). O contato próximo pode incluir: cuidar, morar, visitar ou compartilhar uma área ou sala de espera de assistência médica ou, ainda, nos casos de contato direto com fluidos corporais, enquanto não estiver usando o EPI recomendado.



8.1 Identificação do Paciente

Nome completo: _____
Data de nascimento:___/____/____ Idade em anos: _____
Gênero: ( ) Masculino ( ) Feminino
Nome da mãe:_____
Número do cartão SUS (CNS):_____
CPF:___.___.___-__
Ocupação: ( ) Estudante ( ) Profissional de saúde ( ) Trabalha com animais ( ) Técnico de laboratório em saúde ( ) Outra, especifique: _____

Endereço: _____
Estado: _____ Cidade: _____
CEP de residência:
Zona: ( ) Rural ( ) Urbana ( ) Periurbana
Celular: _____
Data do registro: ___ / ___ / ___ Número do FormSUScap: _____
Data da Notificação: ___ / ___ / ___ Número do SINAN NET: _____
Data da Notificação: ___ / ___ / ___ Número do SIVEP - Gripe: _____



8.2 Histórico Vacinal

Possui caderneta de vacinação: ( ) Sim ( ) Não
Vacina influenza trivalente ( ) Sim ( ) Não
Data da última dose:___/____/____

8.3 Condições Pré-existentes:

Condição pré-existente	**Sim**	**Não**	**Desconhecido**
Obesidade			
Neoplasias(tumor sólido ou hematológico)			
Diabetes			
Infecção pelo HIV			
Imunodeficiência			
Doença cardiovascular, incluindo hipertensão			
Doença pulmonar crônica			
Doença hepática crônica			
Distúrbio hematológico crônico			
Doença renal crônica Doença neurológica crônica ou neuromuscular			
Recebeu doação de sangue/ órgão			



Gravidez Se sim, especifique o trimestre:			
	( ) Primeiro	( ) Segundo	( ) Terceiro
Outras condições pré-existentes Se sim, especifique:			

8.4 Sinais e Sintomas

Data de Início de sintomas: ------/------/--------- Sinais/Sintomas	Sim	Não	Desconhecido
Febre			
Tosse			
Dor de garganta			
Dispneia (dificuldade de respirar)			
Diarreia			
Vômitos/náusea			
Dor de cabeça			
Coriza			
Irritabilidade/confusão			
Fraqueza			
Convulsões			
Conjuntivite			
Calafrios			
Erupção cutânea			
Dores musculares			
Dor nas articulações			
Perda de apetite			
Sangramento do nariz			
Fadiga			
Alteração do nível de consciência			
Sinais neurológicos			
Outros sinais e sintomas Se sim, especifique:			



8.5 Sinais de Gravidade

Sinais/Sintomas	Sim	Não	Desconhecido
Ausculta pulmonar anormal			
Achados anormais na radiografia de pulmão			
Desconforto respiratório ou aumento da frequência respiratória (FR)			
Pneumonia			
Piora nas condições clinicas de doença de base			
Hipotensão			
Linfopenia			
Exsudato de faríngeo			
Coma			
Injeção conjuntival			
SpO2 <95% em ar ambiente			
Ventilação mecânica			
Outros sinais e/ou sintomas? Sim, especifique:			



8.6 Sinais de Gravidade:

- Hospitalização ( )Sim ( )Não ( )Desconhecido
Data da primeira internação ___ / ___ / ___

- Admissão na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) ( )Sim ( )Não ( )Desconhecido
Admissão na UTI ___ / ___ / ___ Alta da UTI ___ / ___ / ___

- Ventilação mecânica ( )Sim ( )Não ( )Desconhecido
Data de Início:___/___/___ Termino: ___/___/___

-Insuficiência renal aguda ( )Sim ( )Não ( )Desconhecido
Se sim, data de início ___ / ___ / ___

-Insuficiência cardíaca ( )Sim ( )Não ( )Desconhecido
Se sim, data de início ___ / ___ / ___

- Coagulopatia ( )Sim ( )Não ( )Desconhecido Se sim, data de início ___ / ___ / ___

- Pneumonia por radiografia de tórax ( )Sim ( )Não ( )Desconhecido
Se sim, data de início ___ / ___ / ___

- Hipotensão que requer vasopressores ( )Sim ( )Não ( )Desconhecido
Se sim, data de início ___ / ___ / ___

- Outros sintomas ( )Sim ( )Não ( )Desconhecido
Se sim, especifique: _____



8.7 Locais de Exposição do Paciente

9 Viajou, no Brasil, nos 14 dias anteriores ao início de sintomas? ( )Sim ( )Não ( )Desconhecido
Se sim, datas da viagem: embarque ___/___/___ retorno___/___/___
Cidades visitadas:
_____

- Viajou, internacionalmente, nos 14 dias anteriores ao início de sintomas? ( )Sim ( )Não ( )Desconhecido
Se sim, datas da viagem: embarque ___/___/___ retorno___/___/___
Países visitados:_____
Cidades visitadas:_____

- Teve contato próximo com uma pessoa com infecção respiratória aguda nos 14 dias anteriores ao início dos sintomas?
( )Sim ( )Não ( )Desconhecido

- Compareceu a evento com aglomeração de pessoas nos 14 dias anteriores ao início dos sintomas? ( )Sim ( )Não ( )Desconhecido
Se sim, especifique:
_____

- Nos últimos 14 dias, teve contato com um caso provável ou confirmado de coronavírus (2019-nCOV)? ( )Sim ( )Não ( )Desconhecido
Se sim, data do último contato:___ / ___ / ___
Local da exposição ( )casa ( )serviço de saúde ( )escola ( )local de trabalho ( )igreja ( )Outro, especifique:
_____

- Visitou algum serviço de saúde nos 14 dias anteriores ao início dos sintomas?
( )Sim ( )Não ( )Desconhecido Se sim, especifique:
_____



8.8 Diagnóstico Laboratorial

Tipo de amostra: ( ) Aspirado de nasofaringe ( ) Swabs combinado (nasal/oral)

( ) Secreção respiratória inferior

Tipo de Exame Realizado	Laboratório Responsável	Data da Coleta	Data do Resultado	Agente isolado
RT – PCR				
Seqüenciamento genômico				

8.9 Encerramento do Caso:

- Data do encerramento: ___ / ___ / ___

- Classificação final do caso para 2019 nCOV: ( ) Confirmado ( ) Descartado

Se for confirmado especificar o caso como: ( ) Primário ( )Secundário ( )Importado

- Critério de encerramento: ( ) Laboratorial ( ) Clínico – epidemiológico ( ) Clínico

- Situação de saúde no momento da notificação: ( ) Sintomático ( ) Cura ( ) Ignorado
( ) Óbito Data do óbito: ___ / ___ / ___

8.10 Informações Adicionais

_____
_____
_____
_____
_____
_____



8.11 Responsável pela Investigação

Data	
Nome	
Função	
Telefone	
E-mail	

ANEXO I - ROTEIRO DE INVESTIGAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA – CORONAVÍRUS (2019 nCoV)

DESLOCAMENTO DO CASO SUSPEITO

Período de transmissão: Descrever os locais em que o caso circulou nos 7 dias após o aparecimento dos sintomas, dia a dia (deslocamento), pessoas que teve contato (nome e telefone), locais e eventos que circulou.

Dia 1	Data:	
	Local:	
	Contatos:	
Dia 2	Data:	
	Local:	
	Contatos:	
Dia 3	Data:	
	Local:	
	Contatos:	
Dia 4	Data:	
	Local:	
	Contatos:	
Dia 5	Data:	
	Local:	
	Contatos:	
Dia 6	Data:	
	Local:	
	Contatos:	
Dia 7	Data:	
	Local:	
	Contatos:	



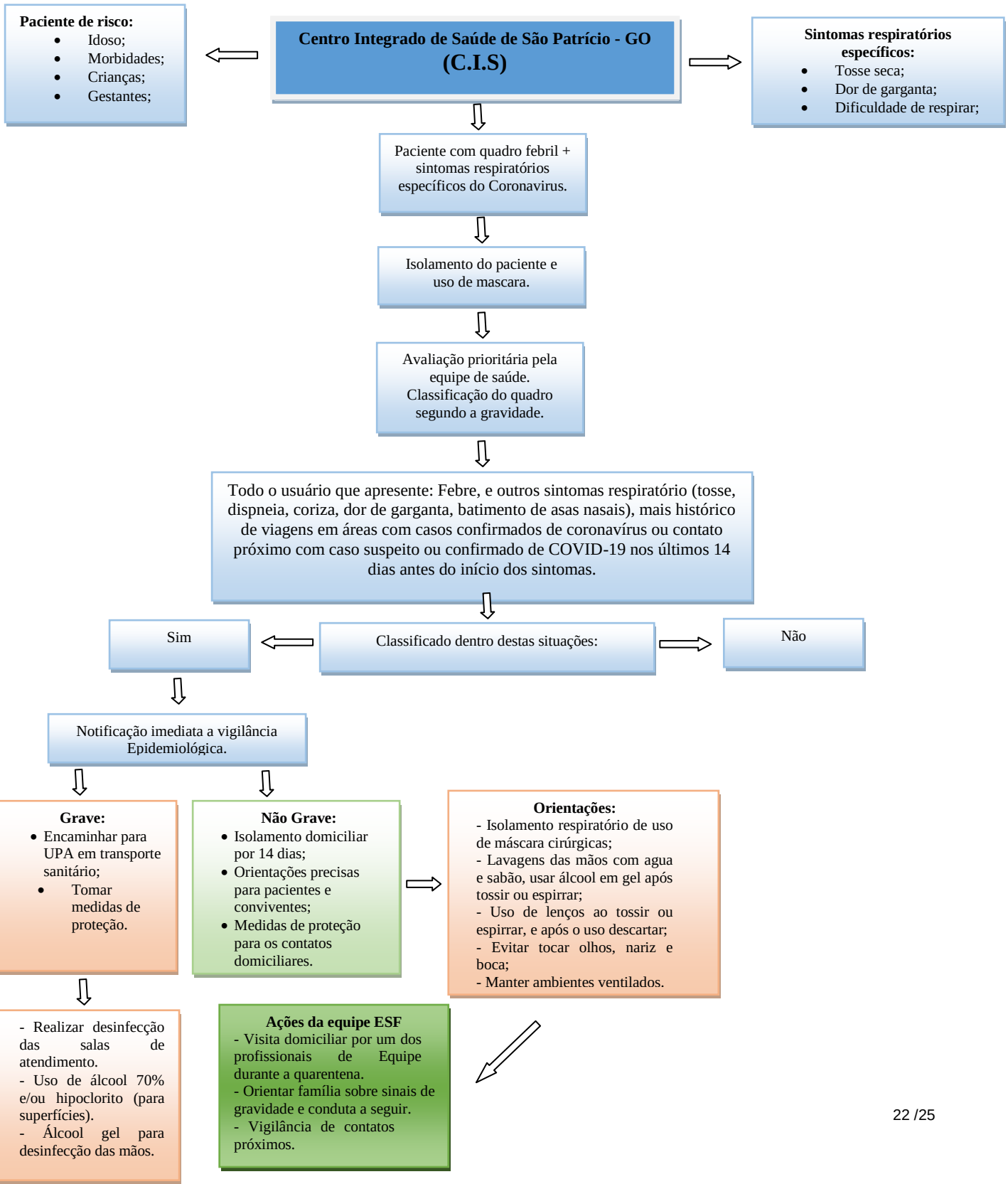
Anexo II - Roteiro de Investigação Epidemiológica – Coronavírus (2019 ncov)

Nome	Data de Nascimento	Data da exposição	Telefone	Fator de Risco**. Qual?

*²Contato próximo é definido como: estar a aproximadamente dois metros (2 m) de um paciente com suspeita de caso por novo coronavírus, dentro da mesma sala ou área de atendimento, por um período prolongado, sem uso de equipamento de proteção individual (EPI). O contato próximo pode incluir: cuidar, morar, visitar ou compartilhar uma área ou sala de espera de assistência médica ou, ainda, nos casos de contato direto com fluidos corporais, enquanto não estiver usando o EPI recomendado.

**Preencher de acordo com item 3. Condições pré-existentes do roteiro de investigação

9 Fluxograma APS





10 Fluxograma Domiciliar

Orientações para casos de COVID-19 em isolamento domiciliar

⇩

Paciente em isolamento atendido em outros serviços, exceto APS.

⇩

Contato realizado pela SMS/Regionais de Saúde para a atenção primária.

⇩

Acompanhamento conforme orientações de isolamento domiciliar

⇩

Orientações:

- **Não compartilhar alimentos, copos, talheres, toalhas o objetos de uso pessoal;**
- **Evitar tocar olhos, nariz ou boca;**
- **Lavar as mãos várias vezes ao dia com sabonete e água, ou quando não for possível usar álcool em gel, principalmente depois de tossir ou espirrar;**
- **Não receber visitas enquanto os sintomas persistirem;**
- **Enquanto permanecer com sintomas respiratórios, deve usar máscara cirúrgica ao sair do seu quarto e trocar a máscara sempre que tiver umidade.**
- **Na ausência de máscara, protegem a boca ou o nariz ao tossir ou espirrar com lenços descartáveis (Ex: papel higiênico, papel toalha, guardanapo ou lenço de papel);**
- **Paciente com doença do COVID-19, manter sozinho (se possível) e manter o ambiente ventilado;**
- **Sair de casa apenas em situações emergenciais, ao sair de casa sempre colocar a máscara cirúrgica;**
- **Alta médica com 14 dias a partir do início dos sintomas.**



11 Considerações Finais

Diante do artigo proposto, considera–se que em momento estabelecido pela pandemia causada pelo COVID-19, estabelece fluxo de atendimento na UBS, a fim de definir metas para melhor atender casos e possíveis suspeitos e/ou confirmados. Medidas foram implementadas antes da chegada de pacientes, objetivando garantir acesso e atendimento igualitário a toda população.



12 Referências Bibliográficas

- Centro Integrado de saúde de São Patrício – GO;
- Secretaria Municipal de Saúde de São Patrício – GO;
- Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Centro de Operações de Emergência de Saúde Pública. Boletim Epidemiológico 02. Brasília. 2020.
- Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Boletim Epidemiológico Nº 01 Secretaria de Vigilância em Saúde SVS/MS-COE - Jan. 2020. Disponível em: http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/janeiro/28/Boletim-epidemiologicoSVS-28jan20.pdf
- file:///C:/Users/Usuario/Downloads/PLANO-DE-CONTINGENCIA-CORONAVIRUS-SESAU-CG.pdf%20(1).pdf